《骨关节炎病证结合诊疗指南》

编制说明

中华中医药学会团体标准报批稿

《骨关节炎病证结合诊疗指南》标准编制组

二零一九年六月

一、概述

（一）任务来源

中华中医药学会团体标准制修订资助。

（二）目的意义

风湿病属于临床常见、多发、疑难病。风湿性疾病包括100余种疾病，临床表现复杂多样，往往侵害人体多个系统，每种疾病发病率不一，男女比例各不相同，常见风湿病的患病率为：类风湿关节炎0.3～0.4%；强直性脊柱炎0.3%；系统性红斑狼疮75～115/10万人；骨关节炎40岁人群中占10%～20%，60～70岁者75%；如果把每种疾病的发病率汇总，风湿病的患病人数当以亿计，该类疾病对人类健康造成严重的危害已引起国内外专家的高度重视。我国风湿病患病基数大，患病人群构成复杂，边远地区和贫困人群因医疗水平或经济原因，很多风湿病患者没有接受规范治疗，严重影响患者预后。目前风湿病发病原因不明，可能与感染、遗传、雌激素水平等有关，环境因素（如寒冷、潮湿等），以及劳累、营养不良、外伤、精神刺激等均可以诱发。风湿病治疗所使用的药物包括免疫抑制剂、生物制剂、激素、非甾体消炎药等。早期、积极联合应用常规改善病情的抗风湿药，以及生物制剂的介入，使患者预后有很大改善。然而，长期、联合应用改善病情抗风湿药物出现诸多不良反应（如肝肾损害、骨髓抑制、皮疹、消化系统反应等），使用生物制剂的巨大经济负担，现有药物疗效的局限性，使很多患者的疾病控制不佳。

中医药对风湿病的研究已有数千年的历史，历代医家具有创新和发挥，历史医籍皆有论述，且形成了系统、完整的理论体系。早在《黄帝内经•痹论》指出“风、寒、湿三气杂至合而为痹”，最早提出了痹病的病因，随着自然气候、人类生活饮食习惯的改变及对疾病认识的发展，逐渐发现运气偏胜感受湿热邪气而可发为湿热痹，也可由寒湿痹日久不愈，或素体阴虚阳胜，或久用过用温燥药，寒从热化而成，因此热痹逐渐增多。从病因，病机分析，患者外感风寒湿热之邪，合而致痹；精神情志损伤，导致气血阴阳失调而致痹；饮食失宜，嗜食肥甘厚味，辛辣之品，损伤脾胃而致痹；劳逸过度耗伤人体的精血而致痹。本虚多为气阴不足，肝肾亏虚，标实为风寒湿邪，痰瘀痹阻。近几十年来，中药、中西药联合治疗是中医治疗风湿病的主要方法。中医治疗作为风湿病治疗不可或缺的组成部分，目前仍以整体观念、辨证论治、个体化诊疗为主要的诊治观念。中医治疗方

中华中医药学会团体标准报批稿

法，包括复方汤剂、中成药、单味药、中药外治，缓解风湿病病情的疗效是有目共睹的。风湿病多以四肢关节多发肿痛等局部体表病变为临床特点，中药内服对改善关节局部症状起效慢，而中医外治法在很大程度上提高了治疗的效果，在风湿病的治疗过程中具有不可替代的作用。

中华中医药学会风湿病分会成立于 1983 年，由路志正担任第一届主任委员，王承德教授任第二届、第三届主任委员，姜泉教授任第四届主任委员。在历届主委领导下，在朱良春、谢海州、王为兰、陈之才、张沛虬、李济仁、娄多峰等老专家的支持指导下，始终坚持将提高临床疗效与人才培养作为风湿病分会的主要任务，重视中医药继承发展和科技创新，引领全国中医风湿病学术发展。经 30 余年努力，专业委员遍布全国各省市，主办了 19 届全国风湿病学术大会，7 届国际风湿病学术研讨会和“海峡两岸风湿学术研讨会”，扩大了中医风湿病研究在国内外的学术影响。学会专家承担了国家科技部七五至十二五攻关（支撑）计划、国家自然科学基金、国家中医药管理局、各省市级课题等，在全国各省市建立了学术分支机构，指导和引领了各地风湿病学科的发展，在风湿病学界具有重要的学术地位和影响；举办 10 余期全国学习班，各地学习班 20 余期，培养了大批专科人才；主办《风湿病与关节炎》杂志，报道中医风湿病临床科研动态；研制 5 个痹病系列药，并在临床推广，目前仍然服务于临床，提高了全国各地中医风湿病的整体医疗和科研水平。

本病中医药治疗较为棘手，需要辨病和辨证有机结合起来，既要重视疾病发生发展的过程，又要立足疾病各个阶段和不同时期辨证施治，才能整体把握疾病预后、转归和治疗。而在中医药治疗风湿病临床中，存在着缺乏临床规范化应用方案、缺少高级别循证医学证据、尚无公认的临床诊疗指南等问题。病证结合的临床诊疗指南制定研究是中西医两种医学体系有机结合的具体体现，以促进广大中医及中西医结合工作者的普遍认可和在临床诊疗和研究中得以广泛应用，推动中医诊疗规范化的进程。因此，亟需制订符合基于循证医学理念的适用中医药临床使用的病证结合诊疗指南。

（三）工作过程

时间进度	主要阶段	工作安排及内容

中华中医药学会团体标准报批稿

2017.4 月 21 日	课题启动、文献阅读、质量评价	2017 年 4 月 21 日，由中华中医药学会风湿病分会主办的《骨关节炎病证结合诊疗指南》（草案）启动会在山东济南召开。在标准化办公室的具体指导下，来自中华中医药学会风湿病分会指南制订工作组、北京中医药大学及各指南制订参加单位的知名专家共 30 余位参加了本次会议。会上首先由中国中医科学院广安门医院风湿病科姜泉主任对团体标准的研制方案进行了详细介绍，项目组提出以具有高质量循证医学证据的内容做为本次指南制定的最高原则，并确定了《骨关节炎病证结合诊疗指南》的指南名称。会后对各单位承担的任务进行分配，各参加单位分别进行文献阅读和文献质量评价工作。
2017.4-2017.6	起草初稿	2017 年 6 月 1 日，由中华中医药学会风湿病分会主办的《骨关节炎病证结合诊疗指南》（草案）制订工作会在贵州遵义召开。首先邀请中华中医药学会王奕主任做“继续教育的延伸，如何做好科普”进行了培训和讲课；接着由中华中医药学会风湿病分会指南制订工作组及各指南制订参加单位的专家共 40 余位参加了本次会议。本次会议针对前期对各中心分配的2006-2017年11年间国内外发表的中医药治疗骨关节炎的文献进行了梳理，对其文献质量进行了严格的评价；初步确定了本指南包括的主要内容和体例；本次会议各指南参与编写单位就指南的体例、定位、特别对于中医证候的分类及具体证候的主次症进行了讨论和总结，具体书写提出了宝贵的意见。
2017.6-2017.9	修改草案	2017 年 9 月 7 日-9 月 8 日，由中华中医药学会风湿病分会主办的《骨关节炎病证结合诊疗指南》（草案）制订工作会在吉林长春召开。首先由标准化办公室主任郭宇博主任做中医临床指南的编制与应用，对指南的具体操作提出了高屋建瓴的原则和意见；接着由循证医学专家陈薇教授进行 GRADE-证据质量和推荐强度分级的共识的讲课；来自中华中医药学会风湿病分会指南制订工作组、各指南制订参加单位及学会各地主委的专家共 40 余位参加了本次会议。本次会议经过两轮专家投票及意见征询，重点讨论了指南制订中大家公认的难点证候的确定和治疗策略的编写进行了

中华中医药学会团体标准报批稿

		讨论，初步确定了这两部分的内容，并讨论确定了预防调摄部分并进行了中成药专家意见打分及遴选，并就具体辨证使用方剂进行了专家共识。
2017.9-2018.5	指南完稿及复审	2018年5月26-5月26日，由中华中医药学会风湿病分会主办的《骨关节炎病证结合诊疗指南》（草案）复审会议在福建福州召开。来自中华中医药学会风湿病分会指南制订工作组、各指南制订参加单位及学会各地主委的专家共30余位参加了本次会议。本次会议经过新一轮专家咨询表，请专家为指南初稿整体进行意见咨询；会议上对指南各部分的取舍及排列进行了调整；并对指南中的其他细节内容进行了进一步的修改。
2018年9月8日	指南定稿会	2018年9月8日由中华中医药学会风湿病分会主办的《骨关节炎病证结合诊疗指南》（草案）定稿会议暨痛风启动会议在北京召开，各指南制订参加单位及学会各地主委的专家共40余位参加了本次会议,就指南的流行病学定稿提出了宝贵意见;另外对指南的外用药物推荐达成了一致共识。
2018.10-2018.12	征求意见，形成送审稿	《骨关节炎病证结合诊疗指南》（草案）送专家审查，完成专家意见征集，汇总处理表； 根据专家意见，修订完善指南；
2018.12	指南发布	最终发布所制订指南

中华中医药学会团体标准报批稿

（四）主要起草单位及人员

指南起草负责人：姜泉

指南主要起草人：姜泉、刘健、刘维、董振华、娄玉钤、汪悦、高明利、王伟刚、殷海波、陈进春、彭江云、苏晓、朱婉华、方勇飞、黄清春、郑福增、刘英、张剑勇、张华东、何东仪、王海东、王北、王义军、温成平、唐晓颇、朱跃兰、李泽光、李振彬、陶庆文、黄雪琪、王海隆等。

指南制订单位（排名不分先后）：中国中医科学院广安门医院、安徽省中医药大学第一附属医院、浙江中医药大学、北京协和医院、上海市中医医院、上海光华中西医结合医院、南京中医药大学第一临床医学院、辽宁中医药大学附属医院、陆军军医大学西南医院、云南省中医医院、山东中医药大学附属医院、山西

省中医院、深圳市中医院、广东省中医院、天津中医药大学第一附属医院、厦门市中医院、福建中医药大学附属第二人民医院、中国中医科学院望京医院、中国中医科学院西苑医院、北京中医药大学东方医院、中日友好医院、甘肃省中医院、中国人民解放军白求恩国际和平医院、河南省中医院、河南风湿病医院、黑龙江中医药大学第一附属医院、首都医科大学附属北京中医医院、首都医科大学附属北京儿童医院、南通良春中医医院、四川省骨科医院、西安市第五医院、长春恒康中医医院、洪湖市中医医院、江西中医药大学附属医院、宁夏秦杨中医医院、湖南中医药大学第一附属医院、贵州中医学院第二附属医院、广西中医药大学附属瑞康医院、北京中医药大学循证医学中心。

参与起草专家：王伟钢、王义军、王北、王海东、王海隆、王莘智、幺远、于静、马武开、马桂琴、方勇飞、付新利、朱婉华、朱跃兰、刘健、刘维、刘英、刘品莉、齐岩、张华东、张剑勇、张俊莉、张海波、李泽光、李振彬、李琴、汪悦、何东仪、纪伟、苏晓、陈进春、吴宽裕、杨仓良、杨卫彬、范永升、郑福增、庞学丰、赵钟文、郭刚、黄传兵、黄清春、黄雪琪、周祖山、周彩云、姜泉、娄玉钤、殷海波、高明利、徐世杰、唐晓颇、陶庆文、董振华、梁翼、彭江云、照日格图、温成平、喻建平等。

指南执笔：姜泉、罗成贵、王海隆、巩勋。

学术顾问：路志正、李济仁、张鸣鹤、娄多峰、周翠英、周乃玉、沈丕安、孙树椿、胡荫奇、陈湘君、房定亚、张炳厚、冯兴华、王承德、张国恩、田新平、刘建平等。

中华中医药学会团体标准报批稿

二、编制依据和原则

（一）文献检索范围

本部分工作委托中国中医科学院中医药信息研究所完成。文献涵盖了风湿病分会建立以来的33年的中医药治疗骨关节炎的文献，检索数据库包括CNKI，VIP，万方，PUBMED等，重点检索年限：2006年-2017年。

结果共检得中文文献3059篇，英文文献234篇。初筛后共得到中文文献篇2717，英文文献167篇进行文献质量评价。

（二）文献评价取舍的原则

（1）文献资料应尽可能符合循证医学原则者。

（2）有临床参考价值的病例组的文献资料。

（3）国家科技部“五年计划”课题、国家自然科学基金课题、国家中医药管理局课题等国家级课题中相关的文献资料。

（4）著名中医风湿病专家的文献资料。

（5）文献资料的真实性强，临床研究设计科学。

（6）文献资料的疗效可靠，使用安全。

（7）资料要少而精，要具有代表性。

（8）符合中医药辨证、西医疾病诊断等。

（三）文献推荐意见和证据分级的定义

采用国际通用 GRADE 分级及推荐。

（四）专家咨询认证

指南初步形成后，我们采取了德尔菲法和头脑风暴法相结合的原则，制定了专家咨询调查表，咨询调查的主要内容是骨关节炎临床常见的证候、证候要素、治法和方药、治疗策略等。在对专家咨询调查表的分析处理的基础上起草《中医骨关节炎诊疗指南（草稿）》并组织相关专家进行四轮论证会议进行论证评价。考虑到中医老专家经验在中医药治疗中的特殊作用，我们又增加了一轮中医风湿病病学会顾问论证过程，力求指南的制订能体现学术传承及循证为主，经验为辅，专家共识的学术理念。

三、主要技术内容

（一）标准适用范围

适用于中医药治疗风湿病的临床诊断、治疗、预防和调摄。

（二）标准结构框架

本标准主要内容如下：

1.前言

2.引言

3.范围

4.规范性引用文件

5.术语和定义

6.推荐意见和证据质量的定义

7.流行病学

8.病因病机

中华中医药学会团体标准报批稿

9.诊断要点

10.辨证论治

11.具有循证医学证据的现代方剂推荐

12.中成药推荐

13.含有西药成分的中成药

14.外治

15.预防调摄

16.治疗策略

四、标准属性的建议

本标准通过审查后，建议作为推荐性行业组织标准发布实施。

五、与现行相关法律、法规和强制性标准的关系

（本标准与现行法律、法规和强制性标准是否有冲突。）

无。

中华中医药学会团体标准报批稿